



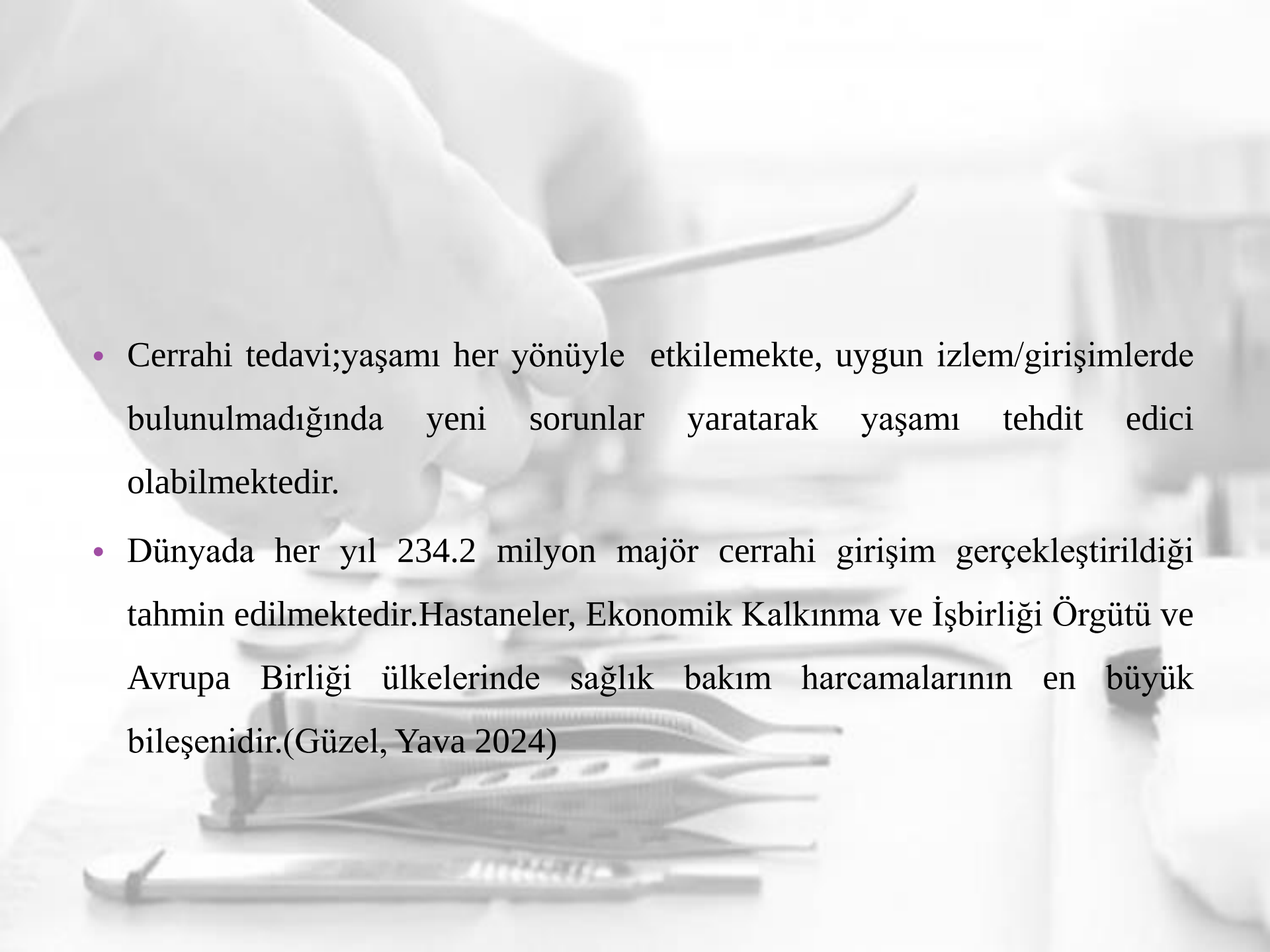
PREOPERATİF DÖNEMDE HASTA BAKIM SÜRECİ

KVC PLASTİK CERRAHİ HEMŞİRELERİ

*EMİNE ELVERDİ
ELİF GANCA
GÖZDE DEMİR*

- Cerrahi girişim hastanın sağlık sorunlarının çözümünde temel tedavi yaklaşımı olmasına rağmen, bireyin normal fizyolojik fonksiyonlarını değiştirebilecek“ kontrollü ve planlı travma”dır.
- Cerrahi yöntemler; sağlığın bozulduğu durumlarda morbitide ve mortaliteyi azaltan, yaşam kalitesini artıran temel tedavi yöntemlerinden biridir.



- 
- Cerrahi tedavi;yaşamı her yönüyle etkilemekte, uygun izlem/girişimlerde bulunulmadığında yeni sorunlar yaratarak yaşamı tehdit edici olabilmektedir.
 - Dünyada her yıl 234.2 milyon majör cerrahi girişim gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir.Hastaneler, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ve Avrupa Birliği ülkelerinde sağlık bakım harcamalarının en büyük bileşenidir.(Güzel, Yava 2024)



- Hastalar cerrahi girişim günü hastaneye yatmakta ve aynı gün taburcu olarak hastanede daha az zaman geçirmektedir. Bu durumun birçok yararı bulunmakla birlikte, hastanın hazırlanma sürecini kısaltarak hemşire-hasta etkileşimini azaltmaktadır.
- Bu nedenle, ameliyat öncesi dönemde kısa sürede nitelikli ve güvenli bakımı sürdürebilmek için kanıta dayalı, kaliteli ve maliyet etkili standart bireyselleştirilmiş bakımın verilmesi gerekmektedir.

- Ameliyat öncesi hazırlığın amacı; ameliyat öncesi komplikasyon riskini belirlemek, perioperatif komplikasyon riskini azaltmak, hastayı normal fizyolojik fonksiyonlarına mümkün olduğunca çabuk döndürmek ve perioperatif bakım maliyetini azaltmaktır. (Kaya D, 2026)



- Cerrahi girişimlerin hepsinde ameliyat öncesi bireyin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, ek olarak alana özgü hazırlıkların ve kanıta dayalı bireyselleştirilmiş bakımın sunulması temel hemşirelik girişimlerindendir.



- 1978 yılında Ameliyathane Hemřireleri Birlięi (AORN), perioperatif hemřirelięi, ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası dönemlerde hastalar tarafından deneyimlenen geçici bakım süreci olarak tanımlamıştır; bu kavram, hemřirelięin cerrahi merkezden farklı alanlara yayılmasının yolunu açmıştır.(Yakupoęlu ve arkd, 2026)



Preoperatif hasta hazırlığı:

- Psikolojik hazırlık
- Fizyolojik hazırlık
- Yasal hazırlık
- Ameliyat öncesi eğitim



Ameliyat öncesi iyi bir psikolojik hazırlık;

- Anksiyeteyi gidermeye
- Ameliyatta az anestezi madde kullanımı, ameliyat sonrası az analjezik kullanımına
- Ameliyat sonrasında yaşam bulgularının kısa sürede düzene girmesine
- Strese tepki olarak salınacak kortikosteroidlerin az salınımına
- Ameliyat sonrası hızlı iyileşme ve erken taburcu olmaya yardımcı olur.

Fizyolojik Hazırlık

Cildin hazırlanması

- Geçici florayı baskılamak ve yerleşik florayı engellemek, böylece cerrahi enfeksiyon kaynaklarından birini ortadan kaldırmak için, cerrahi bölgenin yıkanması ve asepsisi sağlanır.
- Ameliyat öncesi banyo, göbek, perine, kasık kıvrımları ve koltuk altları gibi kontamine bölgelere odaklanılarak, müdahaleden önceki gün veya müdahale günü antiseptik sabunla yapılır ve saçlar şampuanla yıkanır.
- İşlem baş bölgesinde ise, %4 klorheksidinli banyo önerilir.





Ameliyat bölgesinden kıl alma

- Ameliyattan hemen önce (2 saat önce) ve ameliyat odasının dışında, tek kullanımlık başlıklara sahip elektrikli tıraş makinesi veya tüy dökücü krem ile yapılmalıdır.
- Kılları almak için yapışkan bant kullanılmamalıdır çünkü bu, bakterilerle kolonizasyona izin veren mikroagresifliklere neden olabilir; hastalara ameliyat bölgesini tıraş etmemeleri konusunda eğitim verilmelidir.
- Tüylerden arındırmak için jilet kullanılmamalıdır, çünkü jiletin CAE riskini artırdığı bildirilmektedir. (Gürlek Ö, Yavuz M,2022)

Ameliyat öncesi açlık

- Hastanın özel bir hazırlığa ihtiyacı varsa, bu durum tıbbi talimatlarda belirtilir.
- Genel anestezi, hastanın acil durumda olması ve açlık süresinin bilinmemesi durumunda bronşiyal aspirasyon tehlikesini artırır.
- Çocuklarda bu risk, ailenin bilgilendirilmesiyle önlenir. Berrak sıvıların kesilmesi 2 saat, anne sütü kesilmesi 4 saat, bebek maması kesilmesi 6 saat, hafif yiyeceklerin kesilmesi 6 saat ve normal beslenmenin kesilmesi en az 8 saat sürmelidir.





Kanama ürünleri

- Kan kaybı riski bulunan ameliyatlarda, talep teyit edilmeli ve hastanın çapraz testlerle sınıflandırılması ve yeterli kanama ürünü rezervinin bulunması gerekmektedir.





T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

KAN BİLEŞENLERİ NAKLİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU(*)

Hasta Adı Soyadı:

Dosya Numarası:

☐ **KONU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEK İSTEMİYORUM(**)**

Doktorum/hastamın doktoru.....bana/hastama kan ve kan bileşenleri nakli yapılmasının hastalıkta anlamlı düzelme ya da olumlu değişiklik yapabileceğini bildirdi.

Kan ve kan bileşenleri (ek olarak lökositlerden arındırılmış, ışınlanmış, yıkanmış şekilde)
Tam Kan,
Eritrosit Süspansiyonu,
Taze donmuş Plazma
Trombosit Süspansiyonu ya da kriyopresipitat olabilir.

Bu nakil işleminin sağlayabileceği yarar ve riskler ile alternatif tedaviler açıklandı.Kan ve kan bileşenlerinin yasal ve bilimsel kurallara göre hazırlanıp test edilmesine rağmen bana/hastama öngörülemeyen çeşitli immünolojik, alerjik, mikrobik, fiziksel ya da kimyasal nakil reaksiyonlarına neden olabileceğini;bu reaksiyonların genellikle hafif veya orta derecede seyretmesine rağmen nadiren yaşamı tehdit edecek düzeyde ağır seyredebileceğini; bu reaksiyonların başarılı tedavi girişimlerine rağmen ölümcül de olabileceğini, hatta bu durumun kendi kanım verildiğinde bile gerçekleşebileceğini öğrendim.En güncel yöntemlerle test edilse bile nadiren kan ve kan bileşenleri nakli ile bazı virüslerin (AIDS,hepatit virusleri;hepatit B,hepatit C gibi) bulaşabileceğini ve buna bağlı olarak aylar ya da yıllar sonra enfeksiyon gelişebilme olasılığı olduğunu biliyorum.

Kan ve kan bileşenleri nakli ile ilgili soru sorma fırsatım oldu.Vermiş olduğum bu "Bilgilendirilmiş Onay" hastaneden taburcu olana dek geçerlidir.(***)

Kendime/hastama kan ve kan bileşenleri nakli konusunda bilgilendirildim, yazılanları/anlatılanları anladım.

☐ **ONAYLIYORUM**

☐ **ONAYLAMİYORUM**

Tarih:
Saat :

Hasta/Hasta yakını:Adı Soyadı:

İmza:.....

Şahit:Hemşire/Doktor Adı Soyadı:

İmza:.....

Doktor:Adı Soyadı:

İmza:.....

ACİL DURUMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU YAPILACAK İŞE;

Sorumlusu olduğum hastadan / hasta yakınından onam alınması mümkün olmamıştır.Hasta için kan ve kan ürünleri transfüzyonunun uygulanması,hayati gerekliliğe haizdir.Tüm sorumluluğu alarak,hastaya kan transfüzyonu yapılmasını onaylıyorum.

Doktor Adı Soyadı:

İmza:.....

AÇIKLAMALAR:

* Hasta 18 yaşın üstünde ve bilinci yerinde ise bu formu kendi onaylamalıdır.Aksi durumda onay hastanın birinci derece yakını tarafından yapılmalıdır.(Anne, baba, kardeş, eş, çocuk)

** Hastanın bilgilenecek istemediği durumlarda kendi el yazısı ile "bilgilenecek istemiyorum"ibaresini bu formun altına yazarak imzalaması gereklidir.

*** Hastanın /hasta yakınının istediği zaman kan ürünleri nakli için olan onayını iptal etme hakkı vardır.Böyle durumda hastanın yeni bir onay formunu imzalaması gereklidir.

Venöz kateterin açıklığı

- İlaç ve solüsyonların uygulanması için bir yol sağlamak amacıyla, en az 18 numara kalınlığında, iyi bir kateter elin arkasına veya ön kola, eklemlerin bükülme noktalarından uzak bir yere yerleştirilir.
- Benzer şekilde, ilaç dozları ağırlığa bağlı olduğundan hastanın kilosu da ölçülür.



- Yasal hazırlık(Onam Formu) Aydınlatılmış onamın alınması yasal bir zorunluluktur. Buna göre aydınlatma, "bilginin sunulmasını" ve "sunulan bilginin anlaşılmasını, onam ise "gönüllülük" ve "yeterlilik" öğelerini içeren temel özellikleri ifade eder.



- Ameliyat izni hem hasta için hem de sađlık alıřanı için yasal bir güvencedir. Hastanın reřit olmadığı, psikolojik ve fiziksel olarak durumunun uygun olmadığı yada acil ameliyata alınması gerektiđi zamanlarda yasal temsilcisinin bu sorumluluđu üstlenmelidir.



- Onam, “**işlemdede yer alan tarafların yükümlölüklerini tanımlayan yasal bir araçtır**”. Hastalar bilgilendirildikten ve şüpheleri giderildikten sonra, kabul edip etmeme konusunda karar verirler; bu durumda, olası sorunlar hakkında bilgilendirilirler ve reddetmeleri yazılı olarak klinik dosyaya eklenir.

Duygusal Bilgilendirme

- Ameliyat odasının gürültülü olabileceği, ilaçlar ve temizleme solüsyonlarında farklı bir koku algılayabileceği, ameliyathanenin soğuk olabileceği, çeşitli ısıtıcılarla vücut sıcaklığının korunmaya çalışılabileceği, ameliyathane ekibinde maske olduğu bu nedenle yüzlerini tam göremeyeceği ama seslerini duyabileceği, ekibin bazı sorular soracağı yanlış anlaşılma durumunda tekrarlamasını istemesi, ameliyat masasının dar olduğu bu nedenle güvenlik amaçlı dizlerinin üst kısmından kemerlerle bağlanacağı, ameliyathane lambalarının çok ışık verdiği, izlem amaçlı kullanılan makinelerin seslerini duyabileceği, bunların hepsinin onun güvenliği için yapıldığı anlatılır. (Yılmaz E ,2018)

Hasta Doğrulama ve Bilgilendirme Kimlik Doğrulama

- Hastanın adı, soyadı, kimlik bilgileri ve işlem yapılacak taraf doğrulanır, çift organlarda taraf işaretlemesine özellikle dikkat edilir. Hasta bilekliği kontrol edilir. Ameliyathanede istenmeyen olayların gerçekleşme oranı ortalama %40 ve bu olayların %50'den fazlasının önlenabilir nitelikte olduğu saptanmıştır.



AMELİYAT GÜNÜ HAZIRLIĞI

Hasta güvenliği kapsamında;

- Güvenli cerrahi uygulamaları için kimlik bileklik kontrolü ile başlamalı,
- Güvenli cerrahi listesinde ameliyat öncesi dönemi kontrolünü tamamlamalı,
- Hastanın yaşam bulgularını değerlendirmeli ve kayıt etmeli,
- Rektum cerrahisinde hastanın durumuna özel lavman, IV sıvı uygulaması gibi özel istem varsa bunları uygulamalı,
- Kadın hastaların tırnaklarında ojeleri varsa ojenin silinmesini sağlamalı. Hastanın takıları varsa bunları çıkarmasını sağlamalı, ayrıca hastanın takılarıyla birlikte parası da varsa yakınına teslim etmesi gerektiği söylenmelidir.
- Hasta yakını yoksa hemşireler ameliyat olacak hastanın eşyalarını kurum politikaları doğrultusunda listeleyip kaydederek tanık eşliğinde teslim alabilmektedir.



T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
HASTA EŞYALARI TESLİM ALMA/ TESLİM ETME FORMU

Kalite
Yönetim
Birimi

Hasta Adı Soyadı:		Hastanın Yattığı/Beslendiği Birim:	
Hasta No:		Hasta TC Kimlik No:	
Hasta Telefon No:		Hasta Yakını Telefon No:	
Hastanın Adresi:			
BULUNTU EŞYA TESLİM EDENİN			
Adı Soyadı:		TC Kimlik No:	Telefon No:
TESLİM ALINAN EŞYALAR			
Tarih:		Saat:	
Giyim Eşyaları		Protezler	
Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi
Nakit Para		Kredi/Banka Kartı	
Cinsi	Miktarı	Cinsi	Numarası
Teslim Alan Sağlık Personeli Ünvanı/Adı Soyadı/İmza		Teslim Eden Hasta/Hasta Yakınının Adı Soyadı/İmza	
Şahit Olan Sağlık Personelinin Ünvanı/Adı Soyadı/İmza		Şahit Olan Sağlık Personelinin Ünvanı/Adı Soyadı/İmza	
Şahit Olan Sağlık Personelinin Ünvanı/Adı Soyadı/İmza		Şahit Olan Sağlık Personelinin Ünvanı/Adı Soyadı/İmza	
İADE EDİLEN EŞYALAR			
Tarih:		Saat:	
Giyim Eşyaları		Protezler	
Cinsi	Adedi	Cinsi	Adedi
Nakit Para		Kredi/Banka Kartı	
Cinsi	Miktarı	Cinsi	Numarası
Teslim Eden Sağlık Personeli Ünvanı/Adı Soyadı/İmza		Teslim Alan Hasta/Hasta Yakınının Adı Soyadı/İmza	
Şahit Sağlık Görevlisinin Ünvanı/Adı Soyadı/İmza		Şahit Hasta Yakınının Adı Soyadı/İmza	
NOTLAR			



GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ

Hastanın Adı Soyadı	
Hasta No	
Bölüm	
Ameliyat/Bölgesi	
Ameliyat Tarihi	

I.Klinikte Ayrılmadan Önce	II.Anestezi Verilmeden Önce	III.Ameliyat Kesisinden Önce	IV.Ameliyattan Çıkmadan Önce
1.Hastanın ☐ Kimlik bilgileri ☐ Ameliyatı ☐ Ameliyat bölgesi; doğrulandı 2.Hastanın rızası kontrol edildi mi? ☐ Evet 3.Hasta aç mı? ☐ Evet ☐ Hayır 4.Ameliyat bölgesi tıraşı yapıldı mı? ☐ Evet ☐ Hayır ☐ Gerekli Değil 5.Hastada makyaj/oje,protez,değerli eşya var mı? ☐ Evet ☐ Hayır 6.Hastanın kıyafetleri tümüyle çıkarılıp ameliyat önlüğü ve bonesi giydirildi mi? ☐ Evet ☐ Hayır 7.Ameliyat öncesi gerekli özel işlem var mı? ☐ Lavman ☐ Mesane Kateterizasyonu ☐ Varis Çorabı ☐ Özel Tedavi Protokolü ☐ Diğer ☐ Hayır 8.Ameliyat için gerekli olacak özel malzeme, implant,kan veya kan ürünü hazırlığı teyit edildi mi? ☐ Evet ☐ Hayır 9.Hastanın gerekli laboratuvar ve radyoloji tetkikleri mevcut mu? ☐ Evet ☐ Hayır Liste Sorumlusu: Ad-soyad,İmza	10.Hastanın kendisinden ☐ Kimlik bilgileri ☐ Ameliyatı ☐ Ameliyat bölgesi ☐ Hastanın ameliyatı ile ilgili nzası; doğrulandı. 11.Ameliyat bölgesinde işaretleme var mı? ☐ Var ☐ İşaretleme uygulanamaz 12.Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi tamamlandı mı? ☐ Evet 13.Pulse oksimetre hasta üzerinde ve çalışıyor mu? ☐ Evet Hastanın Risk Değerlendirmesi 14.Hastanın bilinen bir alerjisi var mı? ☐ Yok ☐ Var 15.Gerekli görüntüleme cihazları var mı? ☐ Yok ☐ Var 16.Hastada kan kaybı riski var mı? ☐ Yok ☐ Var;uygun damar yolu erişimi ve sıvı planlandı. Liste Sorumlusu: Ad-soyad,İmza	17.Ekipteki kişiler kendilerini ad,soyad ve görevleri ile tanıttı mı? ☐ Evet 18.Ekipten bir kişi sesli olarak hastanın kimliğini, yapılan ameliyatı,ameliyat bölgesini teyit etti mi? ☐ Evet 19.Kritik olaylar gözden geçirildi mi? ☐ Tahmini ameliyat süresi ☐ Beklenen kan kaybı ☐ Ameliyat sırasında gerçekleşebilecek beklenmedik olaylar ☐ Olası anestezi riskleri ☐ Hastanın pozisyonu 20.Profilaktik antibiyotik sorgulandı mı? ☐ Kesiden öncesi son 60 dakika içerisinde uygulandı ☐ Kullanılmaz 21.Kullanılacak malzemeler hazır mı? ☐ Evet ☐ Hayır 22.Malzemelerin sterilizasyonu uygun mu? ☐ Evet ☐ Hayır 23.Kan şekeri kontrolü gerekli mi? ☐ Evet ☐ Hayır 24.Antikoagülan kullanımı var mı? ☐ Evet ☐ Hayır 25.Derin Ven Trombozu profilaksisi gerekli mi? ☐ Evet ☐ Hayır Liste Sorumlusu: Ad-soyad,İmza	26.Gerçekleştirilen ameliyat için sözlü olarak ☐ Hasta, ☐ Yapılan ameliyat, ☐ Ameliyat bölgesi;teyit edildi. 27.Alet,spanç/kompresör ve iğne sayımları yapıldı mı? ☐ Evet/Tam ☐ Hayır ☐ Sayım Uygulanmaz 28.Hastadan alınan numune etiketinde ☐ Hastanın adı doğru yazılı ☐ Numune alındığı bölge yazılı 29.Ameliyat sonrası kritik gereksinimler gözden geçirildi mi? ☐ Anestezistin önerileri: ☐ Cerrahin önerileri: 30.Hastanın ameliyat sonrası gideceği bölüm teyit edildi mi? ☐ Evet Liste Sorumlusu: Ad-soyad,İmza

AMELİYAT GÜNÜ HAZIRLIĞI

- Takma diş, gözlük veya protezleri teslim etmesini sağlanmalı. Son altı saat önce katı, son iki saat önce sıvı almadığından emin olmalı
- Hastanın idrarını yapmasını söylenerek mesanesi boşaltılmış olmalı,
- Yasal hazırlık için cerrahi ve anestezi ile ilgili bilgilendirilmiş izninin alınıp alınmadığını kontrol etmeli,
- Ameliyat öncesi önerilen antibiyotiği uygulamalı,
- Cilt hazırlığı; CAE riskini azaltmak için ameliyat öncesi tüylerin temizlenmesi önerilmektedir.



- Doğru taraf cerrahisi ve güvenli cerrahi kontrol listesi ile ameliyat öncesi girişim kontrolü yapmalı
- Bone takması ve ameliyat gömleği (bütün kıyafet-çamaşırlarını çıkararak) giymesi sağlanmalı,
- Ameliyat gömleğini giyen hastanın sedyeye alınmasına yardımcı olunmalı,
- Uygulamaların hemşire gözlem formuna rapor edilmeli,
- Hasta tüm **malzemeleri** ile ameliyathaneye teslim edilmeli [hasta ile birlikte hasta dosyası, hemşire gözlem formu, hastanın radyolojik incele meleri, istemde varsa ilaç (örneğin; antibiyotik) ve malzemeler (elastik bandaj, basınçlı elastik çorap vb.)]



T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
CERRAHİ/İNVAZİV İŞLEM ÖNCESİ
TARAF/SEVİYESİNİ DOĞRULAMA FORMU

Hastanın ;

Adı Soyadı :

Doğum Tarihi:

Yaşı :

Hasta No :

Cinsiyet : ☐ K ☐ E

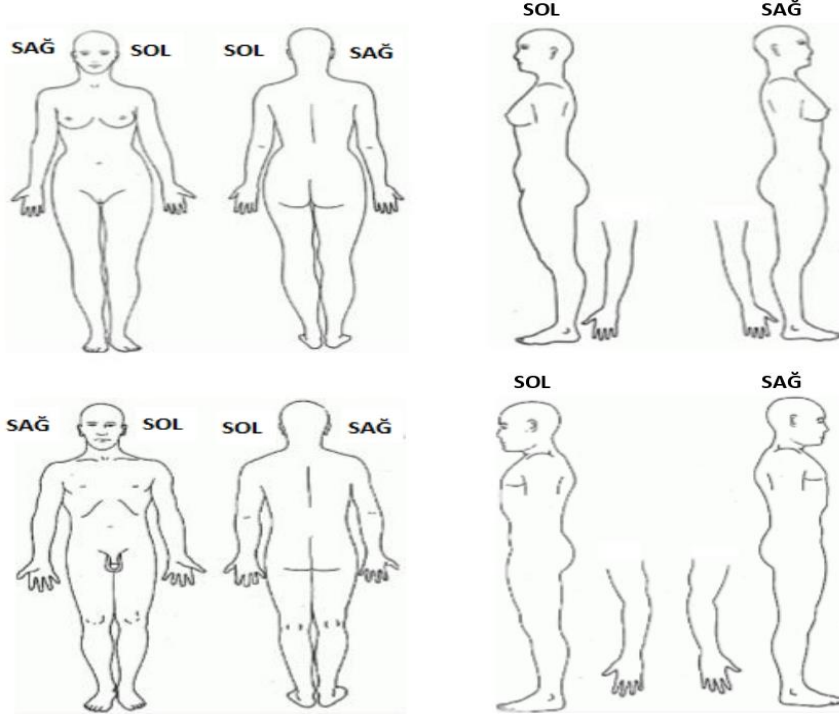
Yapılacak Girişim/Ameliyat Adı:

Tarih :

Yattığı Servis :

Ameliyat Tarihi:

Ameliyat Saati:



Cerrahi bölge işaretlemesi; cerrahi uygulamayı yapacak kişi veya ekipten bir hekim tarafından ilgili cerrahi serviste hasta ameliyathaneye götürülmeden yukarıdaki şekil üzerinde ve hasta üzerinde silinmeyecek renkli kalem ile yapılmalıdır.

NOT:

İşaretlemeYapan
Hekim Adı-Soyadı

İşaretlemeyi Kontrol Eden
Hekim Adı-Soyadı

- Hasta ameliyathane hemşiresine kurum içi transfer formu kayıtları ile teslim edilmeli,
- Hasta yakınlarına nerede bekleyebilecekleri, ne zaman bilgi verileceği konularında bilgi vermeli ve destek olmalıdır.



T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AMELİYATHANEYE HASTA TESLİM FORMU

AH.FR.13

Yayın Tarihi: 03.10.2025

Revizyon Numarası:

Revizyon Tarihi:

Sayf. Sayısı: 1 / 1

Hastanın Adı Soyadı :

Hasta T.C No / Hasta No :

Doğum Tarihi :

Cinsiyeti : ☐ Erkek ☐ Kadın

Yapılacak Ameliyat:

Yattığı Servis:

Hasta Kabul Saati:

PREOP VİTAL BULGULAR									
ATEŞ	NABİZ	TANSİYON	SOLUNUM/SPO2		KAN GRUBU	PREOP KAN ŞEKERİ			

SERVİSİNDEN AMELİYATHANEYE	KONTROL KRİTERLERİ						EVET	KONTROL EDEN
	Hasta Kimlik Doğrulaması Yapıldı						☐	
	Taraf İşaretlemesi Yapıldı						☐	
	Bileklik Kontrolü Yapıldı						☐	
	İlaç Allerjisi ☐ Var ☐ Yok Var ise:							
	Sistemik Hastalık ☐ HT ☐ DM ☐ KOAH ☐ Diğer							
	Preop Verilen/ Uygulanan İlaç/ Tedavi:.....							
	Belirtilmesi Gereken Özel Durum:							
	Güvenli Olarak Sedyeye Alındı ve Sedyeye Kenarları Kaldırıldı.						☐ Evet ☐ Hayır	
	Hasta Güvenli Olarak Ameliyathaneye Teslim Edildi						☐ Evet ☐ Hayır	
DOSYA	Güvenli Anestezi	Güvenli Cerrahi	Anestezi Formu	Anestezi Onam	Cerrahi Onam	Taraf Onam	Transfüzyon Onam	
TESLİM EDEN SAĞLIK ÇALIŞANI/İMZA/SAAT				TESLİM ALAN SAĞLIK ÇALIŞANI/İMZA/SAAT				

AMELİYATHANEDEN SERVİSE TESLİM	KONTROL KRİTERLERİ						EVET	KONTROL EDEN
	Ameliyat Sonrası Hasta Uyanık						☐	
	Solunum Düzenli						☐	
	Damar Yolu Açık, Sorunsuz Kontrol Edildi						☐	
	Ağrı Kesici ☐ Yapıldı (.....) ☐ Yapılmadı							
	Kan Transfüzyonu ☐ Yapıldı (.....) ☐ Yapılmadı							
	PCA Takıldı ☐ EVET ☐ Epidural ☐ IV ☐ HAYIR							
	Dreni; ☐ Var ☐ Yok ☐ Sonda Takılı ☐ İdrar Çıkışı ☐ Var ☐ Yok							
	DOSYA	Güvenli Anestezi	Anestezi Formu	Derlenme Formu	Anestezi Onam	Cerrahi Transfüzyon	Ameliyat Tamamlandı	
POSTOP VİTAL BULGULAR								
ATEŞ	NABİZ	TANSİYON	SOLUNUM/SPO2		DM İSE KAN ŞEKERİ			
TESLİM EDEN SAĞLIK ÇALIŞANI/İMZA/SAAT				TESLİM ALAN SAĞLIK ÇALIŞANI/İMZA/SAAT				

NOT: Formlar Tam İse ✓, Eksikse — Kullanılır.



Ameliyat öncesi eğitim:

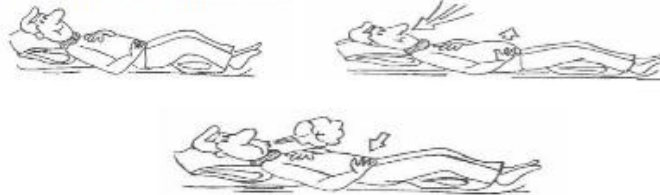
- Hastanın iyileşmesinde çok önemli bir rol oynar ve bu eğitimde öksürme gibi solunum egzersizleri; üst ve alt ekstremitelerin aktif ve pasif egzersizleri; pozisyon değişiklikleri, erken mobilizasyon, kateter ve drenlerin yönetimi, nasıl ayağa kalkılacağı gibi birçok konu öğretilmelidir. Eğitim müdahaleleri bilgi, memnuniyet, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönler, yaşam kalitesi ve öz bakım uygulamaları bilgisi üzerinde olumlu etkiler yaratır.



SOLUNUM EGZERSİZLERİ

Diyafragmatik Solunum

- Yatağınızda uzanıp başınızın ve dizlerinizin altına yastık yerleştirin.
- Bir elinizi önde göğüs kafesinizin hemen altına diğer elinizi de göğüs kemiğinin üzerine yerleştirin.
- Nefes alıp verin ve solunum kasının hareketini izleyin.
- Yavaş, derin bir nefes alın ve kontrollü olarak verin.
- Dinlenin.
- 2-3 kez bunu tekrarlayın.



Büyük Dudak Solunumu

- Önce burnunuzdan yavaşça nefes alın.
- Islık çalacakmış gibi dudaklarınızı büzün.
- Nefesinizi yavaşça ve daha uzun süreli büzülmüş olan dudaklarınızdan boşaltın.
- Nefesinizin dışarı çıkması için güç harcamayın.
- Nefesiniz kesilene kadar işlemi sürdürün.

Pursed lip solunumu

Su dolu bardağa pipetle üfleyerek baloncuk yapma, pink pong topuna sadece oynayacak kadar üfleme ya da balon şişirme ile de yapılabilir.

Ayrıca çiçek koklar gibi nefes alıp mum alevini söndürmeyecek kadar nefes vererek de egzersiz yapılabilir.



Kontrollü Öksürük Manevrası

- Rahat bir pozisyonda oturun ve vücudunuzu öne doğru eğin.
- Derin bir nefes alın, birkaç saniye nefesini tutun.
- Nefes verirken bir iki kez kuvvetlice öksürün.
- Ameliyat olduysanız öksürme esnasında operasyon bölgesini eliniz veya yastıkla desteklemeniz gerekmektedir.





TRIFLOW KULLANIMI BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TRIFLOW EGZERSİZİ NASIL YAPILMALIDIR?

Ameliyat sonrası hastaların akciğer kapasitelerinin artması ve ameliyat sırasında verilen anestezi nedeniyle zayıflayan solunum kaslarının kuvvetlenmesi amacıyla triflow kullanımı önerilmektedir.

- Triflow çalışmak için dik oturmalısınız.
- Triflow düz pozisyonda iken önce bütün nefesinizi vermelidir.
- Triflowun ağızlık kısmı hava kaçırmayacak şekilde ağza yerleştirilmelidir.
- Derin ve yavaş bir nefes alarak topları kaldırıp, havada 3 saniye tutulmaya çalışmalısınız.
- Triflow ters pozisyonda iken derin bir nefes almalısınız.
- Triflowun ağızlık kısmı hava kaçırmayacak şekilde ağza yerleştirilip, nefesinizi yavaşça vererek topları kaldırıp, havada 3 saniye tutulmaya çalışmalısınız.
- Bu egzersiz saat başı 10 kere triflow düz pozisyonda iken ; 10 kere de ters pozisyonda iken yapılmalıdır.
- İlk defa yapıldığında bütün toplar hareket etmeyebilir. Önemli olan egzersizin devamlılığıdır.



SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ.



T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ
HASTA VE REFAKATÇİ BİLGİLENDİRME

- Hastane ortamı, vücut aktivitelerinde değişimler, engellilik, yaşlılarda unutkanlık, görme, işitme kaybı, kas kuvvetinin azalması fiziksel ve düşünsel yetersizlikler veya tedavi süreci düşme riskini artırmaktadır.
- Hastahığına bağlı (baş dönmesi, denge kaybı gibi) veya beklenmedik (ayağın kayması, takılıp düşme gibi) nedenlerden dolayı hastanın düşmesi ciddi ve istenmeyen hasarlara neden olabilmektedir.
- Yatışınız esnasında hastane genel kuralları ve tedavi süreciniz hakkında sağlık çalışanları tarafından size eğitim verilecektir. Hastanemiz tarafından bu konuda alınmış önlemlere ve sağlık çalışanlarının uyarılarına uymanızı önemle rica ederiz.
- Düşme, yaralanmanıza ve hastanede sağlık bakımınızın uzamasına neden olacak fakat alınacak basit önlemler ile engellenebilecek bir durumdur.

Düşme Riski Olan Hastalar;

Hastanemizde tedavi gördüğünüz süreçte, hemşireniz tarafından gerekli görüldükçe düşme riski değerlendirmesi yapılır.

Bu değerlendirme sonucunda eğer düşme riski tespit edilir ise yatağınızın başına\odanızın kapısına düşme riski yüksek hasta figürü asılır.



- Düşme riski yüksek hasta figürü sizin düşme riski taşıdığınızı ve dikkatli olunması gerektiğini tüm çalışanlara bildirmek amacıyla kullanılır.
- Sayın hasta/hasta yakınlarımız aşağıdaki tedbirleri uygulayarak veya uygulatarak olası düşme durumlarını engelleyebilirsiniz.

HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİNDE HASTA VE HASTA YAKINLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Yattığınız/oturduğunuz yerden yavaşça kalkınız ve adım atmadan önce biraz bekleyiniz.
- Yatak kenarlarınızın sürekli yukarıda tutulmasına dikkat etmelisiniz, ayağa kalkarken ise kenarlıkları hemşire kontrolünde indirmelisiniz.
- Eğer başınız dönerse oturduğunuz yerde kalın veya hemen bir yere oturunuz.
- Telefon, çağrı zili ve diğer ulaşmanız gereken nesneleri uzamadan alabileceğiniz mesafede tutulmalısınız.
- Daha yavaş yürüyünüz.
- Karanlık bir odaya girmeden önce ışığı açın.
- Banyo ve tuvalet gibi ihtiyaçlarınız için hemşireniz ve/veya refakatçinizden yardım alınız.
- Vücudunuza bağlı diren, sonda, serum gibi bağlantıların ayrılıp size zarar vermemesi için yatak, sedye, tekerlekli sandalye gibi yerlere tespiti gerektiğinde hemşirenizden yardım almalı, onun uygun görmediği alanlara taşınmayınız.

- Ameliyat sonrası ilk ayağa kalkışınızda bir görevli size refakat edecektir. Özellikle ameliyat sonrası dönem hemşireniz ve hekiminizin onayı ile uygun yöntemle ayağa kalkmalısınız.
- Kullanılan ekipmanlar sizi en az riske sokacak şekilde düzenlendiğinden yerlerini değiştirmeyiniz.
- Hastanede kullanmak üzere kaymayan özellikte terlik kullanmalısınız.
- Kullanılan tekerlekli ekipmanlar park halinde iken frenlerinin kilitli olmasına dikkat ediniz.
- Eğer baston ya da yürüteç gibi yardımcı araç kullanıyorsanız bu araçlarla yardım alarak kalkınız.
- Tüm önlemlere rağmen düşerseniz ya da düşmeye şahit olursanız hemşirenize bilgi veriniz.

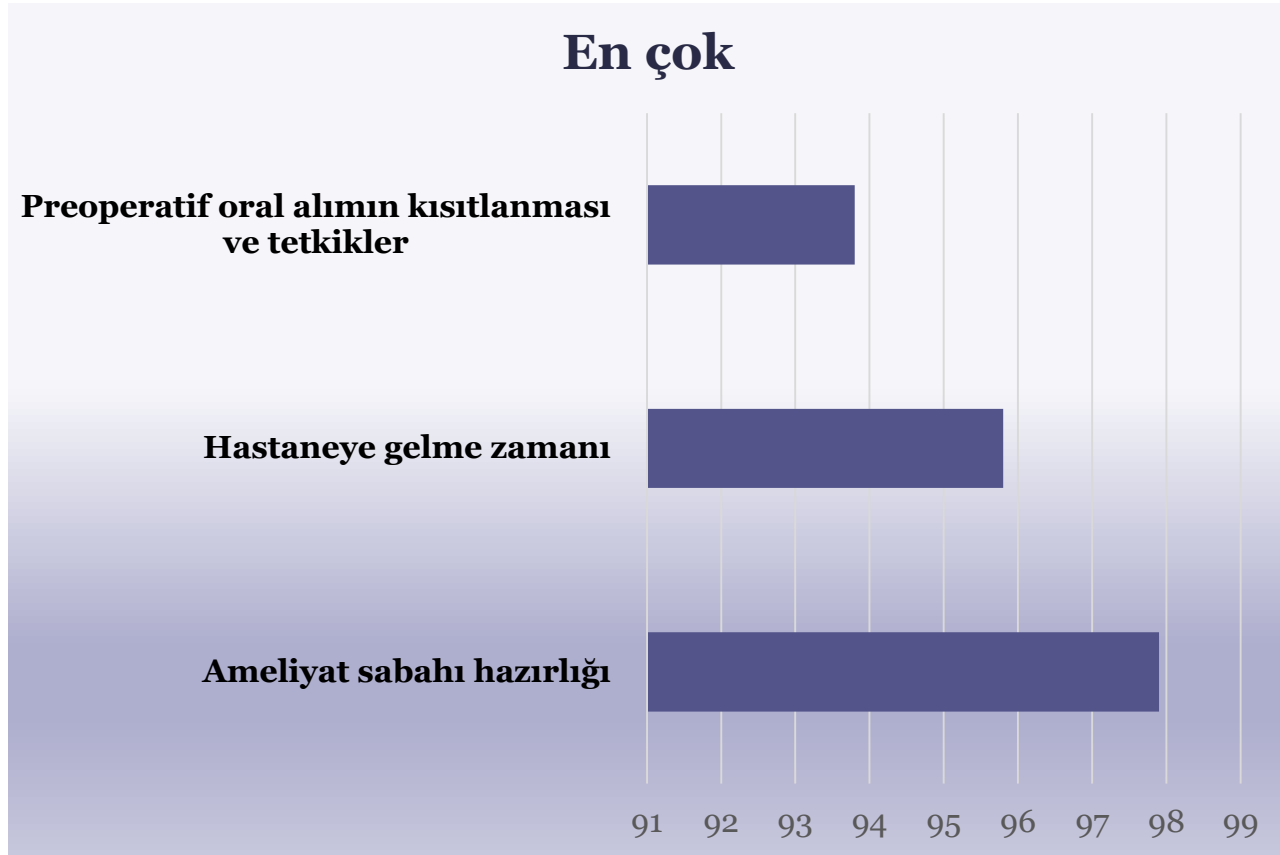
Kaygan Zemin Levhası gördüğünüzde daha dikkatli olunmalıdır.



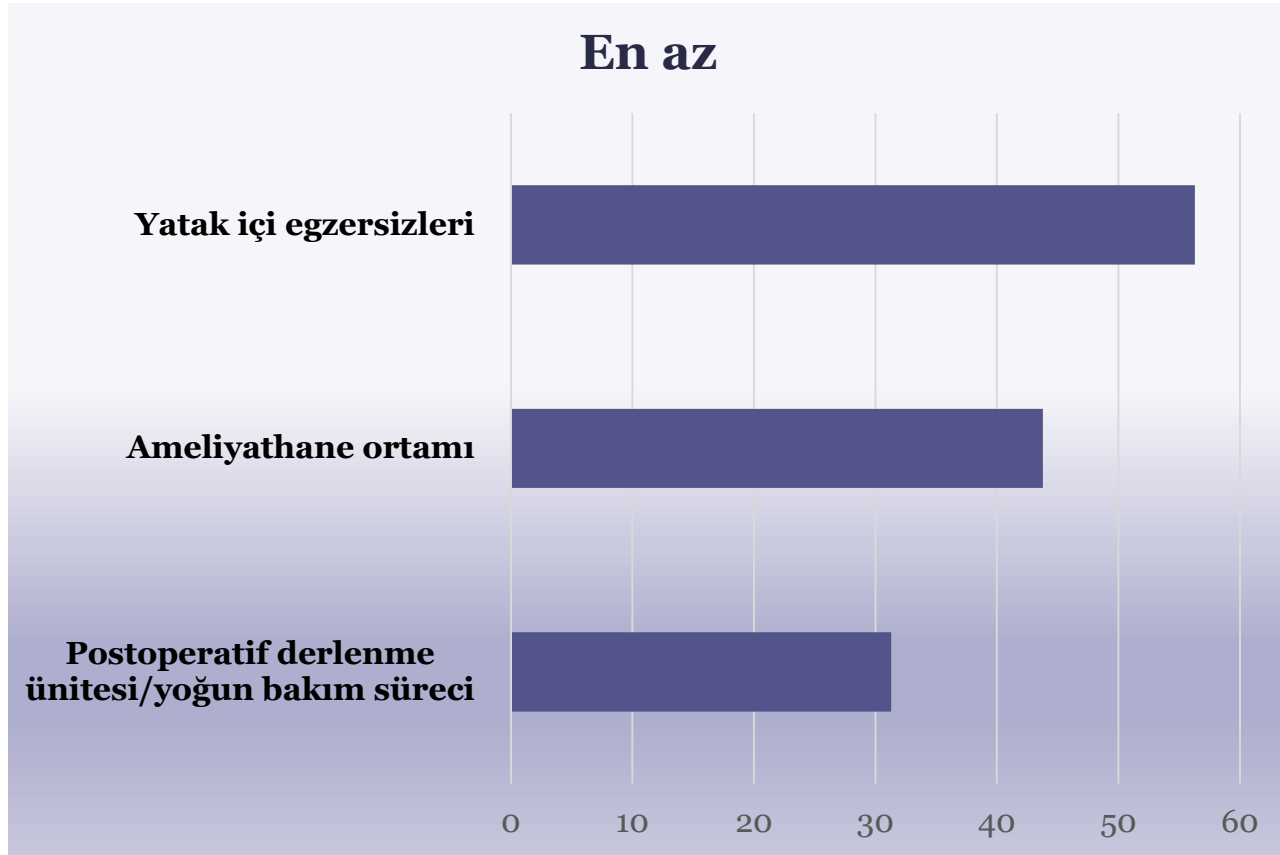
- Düşmelerin önlenmesinde hasta yakınlarına da önemli görevler düşmektedir.

Bu görevler;

- Yapılan analizlere göre risk grubunuza yönelik alınan tedbirlere uyulması,
- Hemşire ve diğer personelin düşme riskini engellemek için oda içinde yapacağı düzenlemelere uyulması ve değişiklik yapılmaması,
- Hastaların tuvalet ihtiyacı, tetkik, gezme gibi yataktan kalkmasını gerektiren durumlarda onlara mutlak eşlik edilmesi, kesinlikle yalnız bırakılmamaları,
- Çeşitli nedenlerle hastanın yanından bir süreliğine ayrılacak ise, görevli hemşire ve personele haber verilmesi,
- Hastada bilinç bulanıklığı, uyku hali, baygınlık gibi yeni durumların gözlemlenmesi halinde görevlilere bilgi vermekte tereddüt edilmemesidir.



(Güzel ve ark. 2024)



(Güzel ve ark. 2024)

- Hemřirelerin tamamının preoperatif hasta eęitimi verdięi, %75'inin eęitim vermek iin kendini yeterli grdüęü, %20,8'inin ise hasta eęitimini hemřirenin sorumlulukları arasında görmedięi saptandı.
- Hemřirelerin %41,7'sinin hasta eęitimini ameliyattan önceki gün öğleden sonra uyguladıęı, %83,3'ünün sadece sözel anlatım yöntemini kullandıęı, %33,3'ünün eęitimi uygulamalı olarak yapmadıęı saptandı. (Güzel ve ark. 2024)



Hastaların %54,6'sının genel anestezi aldığı, %42,6'sının ameliyathanede ve %50,9'unun ayılma odası/yoğun bakımda geçirdiği süreyi açık ve net olarak hatırladığı ve %60,2'sinin aldığı bakımı iyi olarak değerlendirdiği belirlendi.



Araştırma grubunda spinal-epidural anestezi alan, ayılma odasından ve ameliyathaneden çıkışı açık ve net olarak hatırlayan, ameliyathanedeki duygu durumunu ve aldığı tedavi ve bakımı iyi olarak değerlendiren hasta grubunda pozitif bir etki olduğu saptanmıştır. (Yılmaz ve ark. 2018)

KAYNAKÇA

- [Ali Güzel](#) , [Ayla Yava](#), **Cerrahi Servislerde Çalışan Hemşirelerin Preoperatif Hasta Eğitimi Uygulamaları ve Yaklaşımlarının Belirlenmesi**,2024
- Görkem YAKUPOĞLU, Derya KAYA; **Ameliyat Öncesi Kaygı ve Hemşirelik Bakımı**,2026
- Emel Yılmaz, Dilek **Çenen**;**Ameliyat Sürecindeki Hastaların Konfor Düzeyleri ve Hemşirelik Bakımları**.2018
- Gülay Yazıcı, Elif Demirden Erişti; **Perioperatif Dönemde Hasta Güvenliğine Yönelik Hemşirelik Uygulamaları**,2022
- • Gürlek Ö, Yavuz M: **Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin ameliyat öncesi hasta eğitimi uygulama durumları**, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,16(1): 8-15, 2013.



Teşekkür Ederiz